

Guide Naturopathe : Utiliser les Fiches Émotions en Consultation

Mode d'emploi pratique pour intégrer les fiches dans ta pratique

PARTIE 1 : COMMENT INTÉGRER LES FICHES DANS TA STRUCTURE DE CONSULTATION

1.1 La consultation initiale (1h30)

Durée : 30-40 min = approche émotionnelle

TIMING SUGGÉRÉ :

0-10 min : Accueil et normalisation

- "Avant de parler de protocoles, j'aimerais comprendre la relation entre vos émotions et votre symptôme"
- "Beaucoup de mes clients découvrent que 50% de leur problème est émotionnel. C'est normal, c'est humain"
- Créer un espace safe : "Ici, il n'y a pas de jugement"

10-25 min : Les 3 questions fondamentales

1. **"Quand vous pensez à votre symptôme [digestif, migraine...], quelle émotion remonte ?"**

- Écouter sans juger
- Si bloqué : "Fermez les yeux, sentez dans votre corps où ça vit"
- Proposer : peur, colère, tristesse, culpabilité, honte ?
- Valider : "Oui, c'est une réaction normale"

2. **"Y a-t-il une situation qui réactive ça régulièrement ?"**

- Chercher le PATTERN (clé de tout)
- "Ça s'aggrave quand... ?"
- Écouter pour la croyance limitante sous-jacente
- Noter le détonateur

3. **"Derrière cette [émotion], quel besoin ?"**

- Sécurité ? Reconnaissance ? Limites ? Sens ?
- Relier l'émotion au besoin profond
- "Votre corps essaie de vous dire quelque chose"

25-40 min : Donner la fiche + prescription émotionnelle

- "Je vais vous donner une fiche avec des explications et des exercices"
- "À faire 5-10 min par jour, régulièrement"
- "On en reparle à la prochaine consultation"

40-90 min : Protocole naturopathique classique + hygiène de vie

1.2 Les consultations de suivi (1h)

Durée : 15-20 min = approche émotionnelle

TIMING SUGGÉRÉ :

0-5 min : Vérifier la progression émotionnelle

- "Vous avez pu faire les exercices ?"
- "Comment ça s'est passé ?"
- "Avez-vous remarqué des changements ?"

5-15 min : Approfondissement ou ajustement

- Si exercices faits : valider, approfondir le travail
- Si pas fait : sans culpabiliser, explorer les obstacles
- Possiblement donner une nouvelle fiche (si la première a été intégrée)
- Voir si pattern a changé

15-60 min : Protocole naturopathique + ajustement

60 min : Bilan et prochaines étapes

PARTIE 2 : COMMENT CHOISIR LA BONNE FICHE

2.1 Arbre de décision rapide

SI le client dit "digestion" : → Commencer par : **Quelle émotion ?**

- Peur = Fiche Peur + Fiche Digestif
- Colère = Fiche Colère + Fiche Digestif
- Culpabilité = Fiche Honte + Fiche Digestif

SI le client dit "migraine" : → Quasi toujours : **Fiche Colère** (refoulée) + Fiche Migraines → Parfois aussi : Fiche Stress, Fiche Perfectionnisme (fiche Ennui)

SI le client dit "fatigue" : → Chercher : Deuil ? Surmenage ? Ennui ? Dépression ? → Fiche Fatigue + (Tristesse OU Surmenage OU Ennui OU Dépression)

SI le client dit "perte/prise de poids" : → Chercher : Auto-sabotage ? Grignotage ? Hyperphagie ? Peur d'être visible ? → Fiche Poids + (Grignotage OU Hyperphagie OU Honte)

SI le client dit "peau" (eczéma, psoriasis, acné) : → Quasi toujours : **Fiche Peau** + (Culpabilité/Honte OU Irritabilité/Colère)

SI le client dit "allergie/intolérance" : → Chercher : Refus inconscient ? Peur ? Rejet ? → Fiche Allergie + (Peur OU Dégoût OU Colère)

SI le client dit "thyroïde" (hypo, hyper, Hashimoto) : → Chercher : Inhibition ? Peur de parler ? Auto-rejet (Hashimoto) ? → Fiche Thyroïde + (Honte/Inhibition OU Colère contre soi)

SI le client dit "problèmes de libido" : → Chercher : Honte du corps ? Trauma ? Relation toxique ? Fatigue émotionnelle ? → Fiche Libido + (Honte OU Peur OU Stress/Surmenage)

SI le client dit "MICI / Crohn / RCH" : → Quasi toujours : **Fiche MICI** + (Culpabilité/Honte OU Perte de contrôle perçue)

SI le client dit "hyperphagie / binge eating" : → Fiche Hyperphagie + (Émotion déclencheur = peur/solitude/colère/honte)

SI le client dit "addictions" (alcool, drogue, etc) : → Chercher le trauma profond en premier → Fiche Addiction + orientation vers professionnel psy → NE PAS essayer de gérer seule

PARTIE 3 : LES TACTIQUES EN CONSULTATION

3.1 Quand le client "ne sait pas" quelle émotion il ressent

Scénario courant : "Je ne sais pas, je ne sens rien"

Tactique 1 : Le body scan rapide

- "Fermez les yeux. Mettez attention sur votre [symptôme]"
- "Que ressentez-vous dans le corps ? Tension ? Lourdeur ? Chaleur ?"
- "Maintenant, si cette tension parlait, qu'elle dirait ?"
- Souvent ils trouvent eux-mêmes

Tactique 2 : Les propositions ciblées

- "Est-ce que c'est plutôt de la peur, de la colère, ou de la tristesse ?"
- Observer la réaction du corps = la réponse est dedans
- "Quand vous entendez 'colère', votre corps change ?"

Tactique 3 : Chercher le pattern

- "Ça s'aggrave quand ?"
- "Qui ou quoi déclenche ça ?"
- Souvent c'est plus facile d'identifier l'émotion via la situation

3.2 Quand le client est trop émotif en consultation

Scénario courant : Client pleure / se met en colère / devient muet

C'est BON SIGNE = les émotions montent, elles veulent s'exprimer

À faire :

- Laisser faire. Pas d'intervention inutile
- Avoir des mouchoirs à proximité
- "C'est ok, laissez venir"
- Après : "Vous voyez ? Votre corps sait ce qu'il a à dire"

À ÉVITER :

- Minimiser : "Ce n'est pas grave"
- Rationaliser : "Mais logiquement..."
- Culpabiliser : "Excusez-moi de vous faire pleurer"

3.3 Quand le client dit "oui mais c'est quand même physique"

Scénario courant : Résistance ou déni

À dire :

- "Je ne dis pas que ce n'est pas physique. Je dis que le physique et l'émotionnel sont liés"
- "Regardez : vous avez eu des protocoles naturo, ça n'a pas marché. Et si on essayait d'adresser aussi la partie émotionnelle ?"
- "Si c'était juste physique, pourquoi c'est pire quand vous êtes stressé.e ?"

Exemple concret :

- "Vous avez MICI. Les médecins disent c'est auto-immun. Oui. ET en même temps, votre système immunitaire attaque votre intestin comme si vous vous punissiez. C'est pas du tout dans la tête, c'est dans le ventre. Mais il y a une émotion derrière"

3.4 Quand le client refuse la fiche

Scénario courant : "Non non, je n'ai pas besoin de ça"

Options :

1. **Respecter** : Pas de forçage. "Ok, on se concentre sur le protocole naturo alors"
2. **Replanter une graine** : "Si ça ne s'arrange pas dans 2-3 mois, on pourra revenir sur ça ?"
3. **Soft entry** : Donner que le fiche Index, pas les fiches spécifiques d'abord

Important : Certains ne sont pas prêts. C'est ok. Ils reviendront quand ils seront prêts.

PARTIE 4 : INTÉGRER LES FICHES AU PROTOCOLE NATUROPATHIQUE

4.1 Pas de conflit, mais complémentarité

ANCIEN LANGAGE : "Vous devez prendre : magnésium, mélatonine, dormir 8h, pas d'écrans après 22h"

NOUVEAU LANGAGE : "On va vous aider sur 2 niveaux :

1. **Le travail émotionnel :** Accepter l'anxiété qui vous empêche de dormir (fiche Anxiété, exercices quotidiens)
2. **Le soutien physique :** Magnésium, mélatonine, hygiène de vie Les deux ensemble, c'est où vous guérissez vraiment"

4.2 Sequençage intelligent

SEMAINE 1-2 : Focus émotionnel

- Fiche + exercices (5-10 min/jour)
- Pas encore de protocole lourd
- "D'abord, on se connecte à ce qui se passe émotionnellement"

SEMAINE 3-4 : Protocole naturo + émotionnel

- Continuer les exercices
- Ajouter progressivement : compléments, herbes, nutrition
- "On nourrit le corps pendant que vous soulagez l'âme"

MOIS 2-3 : Consolidation

- Les deux continuent en parallèle
- Ajustements basés sur progrès émotionnel ET physique
- "Si ça n'avance pas, vérifiez que vous faites les exercices"

4.3 Quand le protocole naturo "ne marche pas"

Diagnostic rapide :

Question 1 : "Vous avez pu faire les exercices émotionnels ?"

- Si NON → C'est pour ça que ça marche pas
- Si OUI → Vérifier adhérence, ou fiche inadéquate

Question 2 : "Vous avez remarqué une amélioration même petite ?"

- Si NON → Fiche peut-être mal adaptée OU trauma trop profond (orientation psy)
- Si OUI → Continuer, mais patience (ça prend du temps)

Question 3 : "Votre situation émotionnelle a changé ?"

- Si NON → Pattern toujours actif, fiche pas assez puissante
- Si OUI → Continuer, c'est normal que le physique suive après

PARTIE 5 : QUAND ENVOYER VERS UN PRO PSY

5.1 Red flags = orientation psy immédiate

JAMAIS tu ne traites seule :

👉 **Pensées suicidaires** → Urgence psy 👉 **Trauma sévère** (abus, violence, agression) → Psychothérapie (EMDR si possible) 👉 **Addiction sévère** (alcool, drogue, jeu) → Addictologue + groupe de soutien 👉 **Dépression sévère** → Psychiatre (possiblement médicaments) 👉 **Trouble dissociatif** → Psychothérapeute spécialisé 👉 **Antécédents de hospitalisation psy** → Vérifier avant de faire des fiches 👉 **Client te dit "j'ai consulté un psy avant"** → Demander contexte 👉 **Ton intuition dit que c'est "trop big"** → Écoute ton intuition

5.2 Comment orienter sans culpabiliser

PAS BON : "Je crois que vous devez voir un psy, ce n'est pas de mon domaine" → Client se sent rejeté

BON : "Ce que vous décrivez (trauma, dépression) mérite un soutien psychologique vraiment spécialisé. Je serais pas la meilleure pour vous accompagner là-dedans. Je vous recommande de voir [psychothérapeute / addictologue / psychiatre]. Je continuerai à vous aider sur la partie naturo en parallèle, d'accord ?"

→ Client se sent soutenu + orienté correctement

5.3 Réseau de professionnels

À constituer progressivement :

- Un psychothérapeute (Gestalt, TCC, ou autre)
- Un psychiatre (pour diagnostics complexes)
- Un addictologue
- Un thérapeute spécialisé EMDR
- Un hypnothérapeute (pour trauma léger)

Important : Avoir les contacts, pouvoir recommander, créer des partenariats

PARTIE 6 : MESURER LES PROGRÈS

6.1 Les indicateurs de progrès émotionnel

À demander lors des suivis :

Semaine 1-2 :

- "Avez-vous pu faire les exercices ?"
- "Ça vous a fait quoi ?"
- Souvent : "Rien" ou "J'ai senti quelque chose" (bon signe)

Semaine 3-4 :

- "Votre déclencheur a-t-il réactivé l'émotion ?"
- "Était-ce moins intense ?"
- "Avez-vous pu utiliser un exercice sur le moment ?"

Mois 2-3 :

- "Votre symptôme [digestif, migraine...] : comment ça va ?"
- "Remarquez-vous une différence quand vous êtes stressé.e vs calme ?"
- "Vous vous sentez plus en contrôle ?"

6.2 La mesure subjective (la plus importante)

Au lieu de : "Votre IBS est à 7/10, on vise 2/10"

Mieux : "Comment vous vous sentez maintenant vs avant ? Vous avez des moments où c'est oublié ?"

Les fiches travaillent sur la CAUSE (émotion), pas juste le symptôme. Donc la progression est souvent :

1. Mieux accepter l'émotion
2. Moins souvent déclenchée
3. Moins intense quand elle arrive
4. Symptôme physique diminue progressivement

6.3 Quand "ça ne marche pas"

Les 3 raisons principales :

1. Pas d'adhérence aux exercices

- "Vous les avez faits combien de fois ?"
- Honnête conversation : c'est trop difficile ? Besoin d'ajustement ? Pas prêt.e ?

2. Fiche inadéquate

- "Ça vous a parlé ?"
- Possibilité : vous aviez mal identifié l'émotion
- Reposer les 3 questions

3. Trauma/couches émotionnelles trop profondes

- Les exercices simples ne suffisent pas
- Orientation psy nécessaire
- "Vous pourriez bénéficier d'une vraie thérapie pour explorer ça plus profondément"

PARTIE 7 : LES PHRASES CLÉS À RETENIR

Pour normaliser :

- "C'est plus courant que vous le pensez"
- "Vos émotions vous protègent, elles ne vous punissent pas"
- "Vous n'êtes pas vos émotions"

Pour responsabiliser sans culpabiliser :

- "Vous êtes acteur.rice de votre guérison"
- "Ce que vous faites entre les consultations compte plus que ce que je fais ici"
- "Ces exercices c'est pour vous, chez vous, c'est votre pratique"

Pour pousser doucement :

- "Et si vous essayiez juste une fois ?"
- "Même si c'est petit, c'est un pas"
- "Ce n'est jamais trop tard pour commencer"

Pour valider :

- "C'est normal de se sentir ça"
- "Votre corps est sage"
- "Ça s'arrange progressivement"

CONCLUSION : LE CHANGEMENT DE PARADIGME

Ce qui change dans ta pratique

AVANT : Naturopathe = protocoles (herbes, nutriments, hygiène)

MAINTENANT : Naturopathe holistique = 50% protocoles + 50% accompagnement émotionnel

Impact :

- Clients plus satisfaits (vraie guérison, pas juste symptômes)
- Résultats plus durables (tu traites la cause, pas le symptôme)
- Relations plus profondes (tu touches à l'âme, pas que le corps)
- Pratique plus épanouissante (c'est du vrai travail de guérison)

Ton intention à garder

"Je n'aide pas juste à enlever un symptôme. J'aide à découvrir le message que le corps essayait de donner, et à transformer la vie de la personne."

Quand tu gardes ça en tête, tout change. Les clients sentent cette intention, et c'est pour ça qu'ils reviennent.

Bon voyage dans cette nouvelle approche ! 🌱